

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א' רפואת המשפחה

12.06.25

מס' השאלות בחלק זה: 150

1. איזה מבין הבאים מאפיין אבחנה של Type 1 Diabetes Mellitus?
 - א. נדרש אירוע של DKA (Diabetic Ketoacidosis) כדי לאשר את האבחנה.
 - ב. זיהוי 2 סוגי נוגדנים כנגד Islet Cells מנבא התפתחות עתידית של המחלה.
 - ג. לא ניתן לאבחן את המחלה במטופלים מעל גיל 30.
 - ד. מחלות נלוות כמו Atopic Dermatitis ואסתמה תומכות באבחנה.

2. מטופלת בת 25 מתארת איומים מצד בן זוגה. נושא נשק, חושד בה שבוגדת בו לאחרונה. בבוקר לפני שיצא- צעק, זרק חפצים ושבר כלי. אמר שיגיע חזרה בערב לוודא שהיא "מתנהגת יפה", ואם לא- יהרוג אותה. בני הזוג גרים לבד בדירה.

מה חובתך החוקית כאיש צוות רפואי לעשות?

 - א. לפנות לפסיכיאטר מחוזי לבדיקה כפויה דחופה של הבעל.
 - ב. לדווח למשטרה במסגרת החוק למניעת פשע.
 - ג. לפנות לעובדת הסוציאלית של הסניף, במידה והמטופלת מעוניינת.
 - ד. להמליץ למטופלת על טיפול זוגי בהקדם.

3. כל המטופלים המתוארים לפניך אובחנו עם Primary Hyperparathyroidism. מי מהם מועמד בשלב זה לניתוח לכריתת האדנומה?
 - א. בת 42, בריאה בד"כ, ללא עדות לאבנים בסונר דרכי שתן.
 - ב. בן 80, ערכי סידן במעבדה 11.1 מ"ג/ד"ל (תקין 8.5-10.5).
 - ג. בן 55, בצפיפות עצם T Score = -1.5 בשני פרקי הירכיים.
 - ד. בת 60, בדיקת מעבדה תפקוד כלייתי Creatinine Clearance=80ml/min.

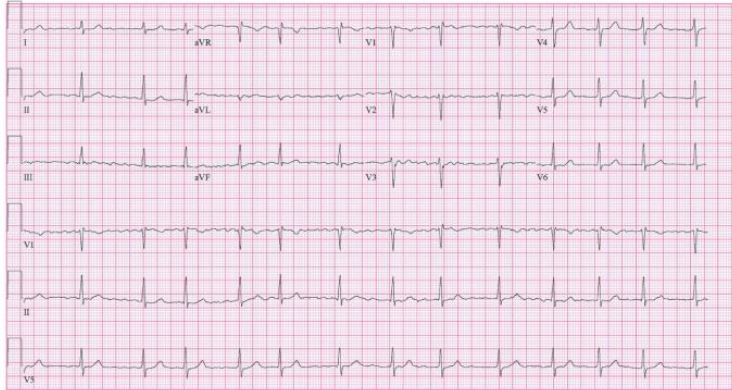
4. אילו משילוב הקריטריונים הבאים כלולים בטבלת SCORE- cardiovascular risk chart?
 - א. עישון, לחץ דם, hemoglobin A1C, מין, Total cholesterol.
 - ב. מין, עישון, גיל, לחץ דם, Total cholesterol.
 - ג. LDL cholesterol, מין, עישון, גיל, טריגליצרידים.
 - ד. גיל, עישון, LDL cholesterol, אירוע MI בעבר, לחץ דם.

5. בת 30, הריון שני, שבוע 24. ברקע אסטמה עם התקפים כפעם בשבוע, מטופלת במשאף משולב. לחץ דם 150/100 במספר מדידות. ללא עדות לחלבון בשתן, תנועות עובר תקינות. בדיקה גופנית ונירולוגית תקינות. מעבדה תקינה. מהו הטיפול התרופתי המתאים ביותר למצבה?
- א. 200 Labetolol (Tandate) מ"ג פומי פעמיים ביום.
ב. 5 Hydralazine (Hydrapres) מ"ג תוך ורידי.
ג. 500 Methyldopa (Aldomin) מ"ג פומי פעם ביום.
ד. 5 Ramipril (Tritace) מ"ג פומי פעם ביום.
6. בן 75, חודשיים לאחר אשפוז על רקע אירוע ראשון של דלקת סעיפים חדה (Diverticulitis) ללא סיבוכים. מהן ההמלצות התזונתיות המתאימות לו כעת?
- א. יש להימנע מצריכת אגוזים, זרעים, תירס ופופקורן.
ב. יש לצרוך מזון טחון דל בסיבים.
ג. תזונה עשירה בפירות וירקות.
ד. תזונה דלת לקטוז.
7. בן 8 מתלונן מזה 3 ימים על כאבים באזור מפרק ירך שמאל, מלווים בחום וצמרמורת. צולע ומתקשה לדרוך על הרגל. מהי ההמלצה לגבי הבירור המתאים ביותר?
- א. צילום רנטגן ידגים שנויים ב-90% מהמקרים.
ב. לאולטרסאונד רגישות נמוכה בזיהוי נוזל תוך מפרקי בירך.
ג. יש לבצע CT או MRI לשלילת זיהום במפרק.
ד. יש לקחת תרביות דם.

8. בן 68, פונה למרפאה עקב תחושה כללית רעה וסחרחורות מזה שעותיים. בבדיקתו- חיוור, לחץ דם 89/55 דופק 90. בהאזנה ללב דופק לא סדיר, חרחורים עדינים בבסיסי הריאות.

באק"ג התמונה הבאה:

כיצד יש להתקדם?



א. Synchronized cardioversion

ב. 6 mg push IV Adenosine

ג. Vagal maneuvers

ד. 150 mg IV Amiodarone

9. בן 13 שנים מתלונן על כאב באשך ימין מזה 4 שעות, בשעה האחרונה הקאות מרובות. מה הכי סביר למצוא בבדיקה גופנית בחשד לתסביב אשך?

א. טרנסאילומינציה חיובית באשך ימין.

ב. נפיחות ורגישות מפשעית מימין.

ג. סימן Prehn חיובי מימין.

ד. רפלקס קרימסטרי חיובי משמאל ושלילי מימין.

10. מטופלת מודאגת מכך שמזה 3 חודשים לא מצליחה להרות, למרות קיום יחסי מין באופן סדיר ותדיר.

באיזה מקרה אפשר להרגיע אותה ללא צורך בהמשך בירור אי פיריון?

א. המטופלת הנה בת 41.

ב. למטופלת ווסתות לא סדירות ושיעור יתר.

ג. המטופלת הטרוזיגוטית למוטציית פקטור 5 ליידן.

ד. בסקר גנטי נמצאה למטופלת נשאות לתסמונת X שביר.

11. רופאה מעוניינת להעביר מידע הקיים בתיק הרפואי של המטופל לידיעתו של בן משפחתו. המטופל מסרב בכל תוקף.
- בהתאם לחוק זכויות החולה, כיצד תוכל הרופאה לקבל אישור להעברת המידע?
- א. עליה לבקש אישור ממחלקת ניהול סיכונים מחוזית של קופת החולים.
 - ב. עליה להציג את המקרה בפני ועדת האתיקה של קופת החולים.
 - ג. עליה לפנות למנהל הרפואי המחוזי של קופת החולים.
 - ד. באם המטופל מסרב בכל תוקף להעביר מידע רפואי לבן משפחה, אין אפשרות חוקית לעשות זאת.
12. בת 34, בריאה. ללא היסטוריה משפחתית של מחלות לב או סרטן. מגיעה לביקורת שגרתית, מרגישה טוב ללא תלונות. באנמנזה מספרת כי נמצאת בזוגיות מונוגמית עם אישה מזה שנתיים (WSW).
- איזו בדיקה מומלצת לביצוע כעת?
- א. שתן ל- STD.
 - ב. סקר לדיכאון.
 - ג. ממוגרפיה.
 - ד. בדיקת Lipoprotein (a).
13. בת 30, לפני מספר חודשים הייתה עדה לפיגוע טרור. מגיעה למרפאה עקב חרדה עד כדי הימנעות מיציאה מהבית, הפרעות שינה וסיוטים חוזרים.
- איזה מבין המצבים הבאים יכול לאפיין מצב של Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) במקרה זה?
- א. דרושה פגיעה גופנית ממשית בעקבות האירוע הטראומטי.
 - ב. התלונות הקליניות יכולות להתחיל למעלה מחצי שנה לאחר האירוע.
 - ג. התנהגות טקסית שחוזרת על עצמה סביב יציאה מהבית.
 - ד. פחד מפני הישנות התחושות החרדתיות ואבדן שליטה.

14. בן 60, מתאר אובדן הכרה למשך 2 דקות אתמול בלילה. האירוע נצפה ע"י אישתו. ללא אובדן שליטה על סוגרים. התאושש מהר. התרחש לאחר שהטיל שתן. סימנים חיוניים תקינים, בדיקה גופנית נוירולוגית במרפאה תקינה. מהו הצעד הבא בניהול המקרה?

א. אק"ג.

ב. EEG.

ג. ארגומטריה.

ד. הולטר לחץ דם.

15. בת 35, ברקע סכרת סוג 2 מאוזנת עם Jardiance Duo (Empagliflozin + Metformin). לחצי דם במדידות חוזרות סביב 125/80. מה כוללת ההמלצה הטיפולית במהלך ההיריון?

א. המשך הטיפול הנוכחי ללא שינוי.

ב. מתן אספירין החל מהטרימסטר השני.

ג. הוספת Vasodip (Lercanidipine) כטיפול ליתר לחץ דם.

ד. החלפת Jardiance Duo ב-Amaryl (Glimepiride).

16. נער בן 15 מגיע למרפאה בתלונה על גרד וריח רע מכף הרגל, באנמנזה בריא, עוסק בספורט ומקפיד על תזונה בריאה. בבדיקתך בין האצבעות הרביעית והחמישית ובכף הרגל נראה עור סדוק וקלויף.



איזה טיפול מומלץ לנער?

- א. אבקת Undecyl (Zinc Undecylate).
- ב. קרם שימון העור, לדוגמה Cetomacrogol.
- ג. משחת Synthomycin (Chloramphenicol).
- ד. קרם Dermacombin (Triamcinolone+Gramicidine+Nystatin+Neomycin).

17. בת 47, בריאה בד"כ. מדידה חד פעמית בבית של לחץ דם 150/90 מ"מ"כ. במרפאה נמדד לחץ דם של 128/82 מ"מ"כ. בניטור אמבולטורי ל-24 שעות נראה ממוצע של 134/82 מ"מ"כ במהלך היום ו-119/69 מ"מ"כ במהלך הלילה.

מהי ההמלצה הנכונה ביותר לטיפול במטופלת זו?

- א. לחץ דם דרגה 1, מומלץ להתחיל טיפול תרופתי מידי במונותרפיה.
- ב. לחץ דם דרגה 1, מומלץ להתחיל טיפול תרופתי משולב.
- ג. לחץ דם גבולי, המלצה לשינוי באורחות החיים כשלב ראשון.
- ד. אבחנה של יתר לחץ דם של חלוק לבן ואין צורך בטיפול.

18. בן שנה, סובל מדלקות אוזניים חוזרות. כעת הגיע בשל חום עד 39.5 מאתמול, חוסר שקט ובכי מרובה. בבדיקת האוזניים אודם, בלט ועכירות של התופית בשתי האוזניים. ללא ממצאים

נוספים

כיצד יש לטפל במקרה זה?

- א. מעקב בעוד 48 שעות.
- ב. Moxypen (Amoxicillin) למשך 5 ימים.
- ג. Augmentin (amoxicillin and clavulanate) למשך 10 ימים.
- ד. מומלץ לבצע ניקור אבחנתי של התופית לפני התחלת הטיפול.

19. את מי מהמטופלים הבאים חובה להפנות ללרינגוסקופיה כעת?

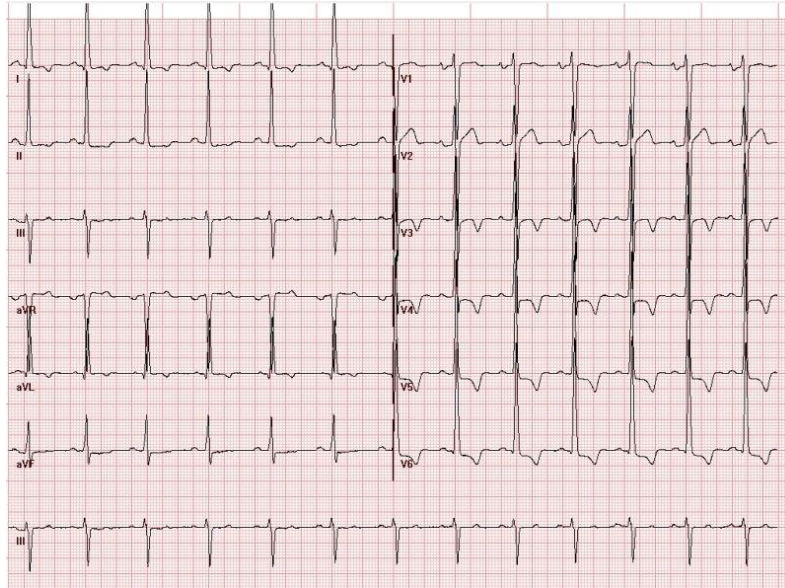
- א. בן 40 צרוד ומצונן מזה שבוע, לא השתפר אחרי טיפול בנוגדי גודש.
- ב. בת 35, ברקע אסטמה, מטופלת ב LABA-ICS באופן קבוע, צרודה מזה שבועיים.
- ג. בן 50, מתלונן על צרבת לאחר ארוחות, צרוד מזה 3 שבועות.
- ד. בן 30, מעשן, צרידות מזה חודש.

20. בן 40, מלין על כאב חזק דוקר ברקה ועין ימין. הכאב מופיע בלילה, נמשך כשעה, מלווה בדמעת וגודש אפי. מספר כי אתמול חווה 2 התקפים דומים וזוכר אפיזודות דומות לפני יותר משנה. בבדיקתו גודש לחמית עין ימין, שאר הבדיקה הנירולוגית תקינה. איזה מבין הבאים הוא הטיפול המומלץ בעת התקף?

- א. Ikacor (Verapamil) PO
- ב. Oxygen by face mask
- ג. Suboccipital steroid injections
- ד. Topamax (Topiramate) PO

21. בן 78, ברקע יתר לחץ דם מאוזן וסוכרת מאוזנת.
מטופל מספר שנים ב-Jardiance, Glucomin (Metformin), Tritace (Ramipril), Gluben (Glibenclamide) ו-Lipitor (Atorvastatin).
בבדיקות מעבדה בשנה האחרונה ערכי GFR סביב 33- יציבים.
איזה שינוי יש לבצע בטיפול התרופתי?
א. הפסקת Gluben (Glibenclamide).
ב. הפסקת Glucomin (Metformin).
ג. הפסקת Jardiance (Empagliflozin).
ד. החלפת Lipitor (Atorvastatin) ל-Crestor (Rosuvastatin).
22. איזו מבין הפעולות הבאות נחשבת כמניעה שניונית בהתאם להמלצות כוח המשימה הישראלי לקידום בריאות ורפואה מונעת?
א. ביצוע פעילות גופנית סדירה.
ב. חיסון DTaP.
ג. מדידת לחץ דם.
ד. מתן ויטמין D לתינוק.
23. בת 60, פליטה מאוקראינה, בדיקה חיובית לנוגדני Hepatitis C virus. בבדיקה חוזרת תוצאות דומות ובנוסף HCV RNA מוגבר וגנוטיפ 1. FIB4 SCORE נמוך מ-1.45.
מהו המשך ניהול המקרה?
א. לאור תוצאת FIB4 SCORE יש להשלים ביופסיית כבד.
ב. מומלץ טיפול בכדור משולב פאנ-גנוטיפי (Pangenotype) למשך 8-12 שבועות.
ג. נתוניה הקליניים מאפשרים מעקב מעבדתי כל 3 חודשים.
ד. יש להשלים רמות ALT (GPT) ו-Viral Load לצורך החלטה טיפולית.
24. בת 20, בבדיקות שבצעה נצפו ערכי TSH – 6.5 mIU/L (נורמה 0.5-4.7).
באיזה מהמצבים קיימת אינדיקציה לטיפול?
א. ערכי Free T4 תקינים.
ב. שני קרובי משפחה עם תת פעילות של בלוטת המגן.
ג. ערכים מוגברים של Thyroid Peroxidase Antibodies (TPO).
ד. ערכים מוגברים של Thyroid Stimulating Immunoglobulins (TSI).

25. בן 17, הובא למרפאתך לאחר אירוע עלפון במהלך משחק כדורגל במסגרת ליגת בתי הספר. באק"ג:



איזה מבין הגורמים הבאים מעלה את הסיכון לדום לב?

- א. עובי דופן שריר הלב מעל 30 מ"מ לפי אקו לב.
- ב. רקע משפחתי של מוות פתאומי ממחלת לב איסכמית.
- ג. פעימות חדריות מרובות.
- ד. תפקוד חדר שמאל (EF) - 55%.

26. הורים צעירים לתינוק ראשון מגיעים לביקור במרפאה, חוששים ממקרה של מוות בעריסה Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

מה יש להמליץ להם על מנת להקטין סיכון לכך?

- א. להימנע משימוש במוצץ לקראת ובזמן השינה.
- ב. להרדים את התינוק על הצד ולהימנע משינה על הבטן.
- ג. להשתמש במכשיר ניטור לתינוק כגון בייביסנס.
- ד. להמשיך הנקה גם אחרי התחלת אכילת מוצקים.

27. בן 35, מתלונן על קושי כרוני בהירדמות, יקיצות תכופות במהלך הלילה, ותחושת עייפות במהלך היום. הוא מתעורר 3-4 פעמים בלילה ולא מצליח לחזור לישון. ניסיון להימנע מקפה בשעות הערב והימנעות ממסכים לא הביא להטבה.

איזה מבין הטיפולים הבאים ניתן להציע לו?

א. שתית כוס יין בסמוך לכניסה למיטה. לפני שנת הלילה.

ב. מומלץ להישאר במיטה עד שעת היקיצה בבוקר.

ג. במידה ולא נרדם תוך 20 דקות יש לצאת מהמיטה לחדר אחר.

ד. הוספת חצי שעת שינה בצהריים במקום שנת הלילה.

28. בת 32, ללא טיפול תרופתי. ברקע Pericarditis לפני 3 שנים. כעת לאחר אשפוז בשל פרכוס ממקור לא ברור. מתלוננת על כאבי פרקים לסירוגין, אירועים חוזרים של אפטות, ואירוע בעבר של רובד אדום על הצוואר, כמתואר בתמונה.



מהו החשד הקליני הסביר ביותר?

א. Dermatomyositis.

ב. Systemic Lupus Erythematosus.

ג. Psoriasis.

ד. Systemic Sclerosis (Scleroderma).

29. נער בן 16 פונה כי שם לב לשתן בצבע אדום. בבדיקת סטיק בשתן נמצא המוגלובין אך ללא כדוריות דם אדומות.

איזה תיאור קליני יכול להסביר את הממצא?

א. סובל מאפילפסיה ונוטל Phenytoin.

ב. סובל מחום ואובחן עם דלקת בדרכי השתן.

ג. מרגיש טוב. אכל הרבה סלק.

ד. התאמן לריצת מרתון.

30. בטיפולך מספר נערים ונערות עם עקמת, בהדמיה זווית העקמת היא בין 20 ל-30 מעלות. למי מהמקרים הבאים הסיכון הגבוה ביותר להחמרת העקמת וצורך בהתערבות?

א. בת 12, עדיין לא קיבלה מחזור וסת.

ב. בת 13, שנתיים לאחר קבלת מחזור הוסת.

ג. בן 17, השלים את ההתבגרות המינית שלו.

ד. בן 18, מתלונן על כאבי גב קלים.

31. בת 10, אובחנה לאחרונה עם מיגרנה קלאסית מלווה באאורה. מזה שעתיים סובלת מהתקף מיגרנה קשה, מלווה בהקאות. פנתה למרפאה לאחר שנטלה כבר אקמול 500 מ"ג ואופטלגין 500 מ"ג ללא תגובה.

מה הטיפול המומלץ בשלב זה?

א. Rokacet (Codeine + Caffeine + Paracetamol) פומי.

ב. Rizalt (Rizatriptan) תת לשוני.

ג. Valium (Diazepam) ו-Pramin (Metocolpramide) תוך ורידי.

ד. Depalept (Valproate) פומי.

32. בת 30, מזה חצי שנה לא מקבלת מחזור ווסת. לפני כן מחזורים סדירים. במעבדה- בדיקת beta-HCG שלילית, FSH בטווח התחתון של הנורמה. LH תקין. Prolactin מוגבר. בוצע progesterone trial, אשר לא גרם לדימום נרתיקי. איזו מבין האבחנות הבאות היא הסבירה ביותר?

א. Pituitary disease

ב. Hypothalamic dysfunction

ג. Ovarian failure

ד. Polycystic ovary disease

33. בת 40, נשואה +2. ברקע יתר לחץ דם ודיכאון. מגיעה למרפאה בליווי בעלה. הבעל מספר שבשבוע האחרון הבחין בשינויים בהתנהגות של אשתו- אי שקט, ממעטת לישון, שטף דיבור מהיר, מבזבזת כספים. בירור כולל בדיקה גופנית, בדיקות מעבדה והדמיית ראש תקינים. הותחל טיפול בליתיום.

איזו מבין התרופות הבאות ניתן לשלב עם ליתיום ללא חשש?

א. Hydrochlorothiazide (Disothiazide).

ב. Amoxicillin (Moxypen).

ג. Ramipril (Tritace).

ד. Ibuprofen (Advil).

34. בת 14 מגיעה עם אמה למרפאה עקב העדר מחזור וסתי. בבדיקתה: נמוכת קומה ללא סימני מין משניים. בדיקה גופנית תקינה. בדיקת ספירת דם כימיה ורמות TSH תקינות.

באיזה מבין המצבים הבאים יש צורך בהמשך בירור?

א. סיפור משפחתי של התפתחות מינית מאוחרת.

ב. צילום כף יד אשר תואם את גיל הכרונולוגי.

ג. הנערה מתעמלת תחרותית תחת הגבלה קלורית קפדנית.

ד. רמות נמוכות של LH ו-FSH בשילוב צילום כף יד שתואם גיל 11.

35. בת 36, BMI 34, יתר לחץ דם שאינו מאוזן תחת טיפול תרופתי. נחירות ושינה לא מרעננת. ממצאים בבדיקת שינה ביתית שבוצעה: Apnea Hypopnea Index (AHI) של 32 הפסקות נשימה לשעה.

מהי הגישה הטיפולית המתאימה לה ביותר?

א. ירידה במשקל של 5% לפני החלטה על טיפול ב-CPAP.

ב. התקן דנטלי Mandibular Advancement Device.

ג. ניתוח UPPP (Uvulopalatopharyngoplasty).

ד. התחלת טיפול ב-CPAP כבר בשלב זה.

36. בת 68 סובלת מהשמנת יתר. מתלוננת על החמרה בכאב בברך ימין בחצי השנה האחרונה. הכאבים מחמירים בעליית מדרגות ונעזרת במעקה, מוגבלת בהליכה. לאחר קימה משיבה קיימת נוקשות בברך הנמשכת כרבע שעה.

בבדיקתה נימושו קרפיטציות מעל ברך ימין, ללא אודם או חום מקומי.

איזו מן האפשרויות הבאות היא האבחנה הסבירה ביותר?

א. Gout.

ב. Osteoarthritis.

ג. Rheumatoid Arthritis.

ד. Septic Arthritis.

37. בת 5, עדיין לא נגמלה מהרטבת לילה. גדילה והתפתחות תקינים. ההרטבה איננה מפריעה לילדה בשיגרה.

מה יש להסביר להורים בנוגע לגמילה מהרטבת לילה?

א. בילדה נותרת עם הגדלת אדנואידים (Adenoids), מומלץ ניתוח לכריתת אדנואידים.

ב. הגבלת סוכר ושתייה וכן עידוד להשתנה יזומה לפני שינה לא הוכחו כיעילים.

ג. הערה יזומה של הילדה בלילה והולכתה לשירותים הינו טיפול יעיל.

ד. התאפקות יזומה (Bladder Training) במהלך היום הינו הטיפול היעיל ביותר.

38. בת 38, בריאה. מתקבלת להערכה במלר"ד בשל כאבים בצד שמאל המקרינים למפשעה מזה 4 שעות. Non-Contrast CT (NCCT) מראה אבן בגודל 12 מ"מ בשופכן הפרוקסימלי ויש התרחבות של הגביעים הכלייתיים.

בנוסף לטיפול במשככי כאבים, מהו הטיפול היעיל ביותר?

א. עירוי נוזלים סליין 0.9%.

ב. ריסוק של האבן Lithotripsy.

ג. Tamsulosin (Omnic).

ד. השגחה.

39. בת 35, פנתה בשל הפרשה נרתיקית חריגה. תוצאת מטוש וגינלי מעידה על Bacterial Vaginosis. זהו אירוע חוזר של תחלואה זו.

מהו ההסבר למטופלת לגבי גורמי סיכון למצבה?

- א. עישון מפחית סיכון.
- ב. שטיפה של הנרתיק עם תכשירי שטיפה אינטימית מפחיתה סיכון.
- ג. אמצעי מניעה כגון התקן תוך רחמי מעלים סיכון.
- ד. נטילת אנטיביוטיקה עבור זיהומים אחרים מעלה סיכון.

40. בן 17 נגעים עוריים מגרדים כפי שמתואר בתמונה.



איזה מצב קליני נמצא בשכיחות מוגברת בחולה זה?

- א. צליאק.
- ב. Basal Cell Carcinoma.
- ג. Uveitis.
- ד. חרדה.

41. בן 60, סובל מסוכרת סוג 2 ללא סיבוכים. מגיע לבדיקת לחץ דם שגרתית. בבדיקה נמדד לחץ דם של 130/80 מ"מ כספית. מה ערך המטרה המומלץ עבור מטופל זה בהתאם לקווים המנחים ליתר לחץ דם בישראל משנת 2019?

- א. לחץ דם נמוך מ-140/90 מ"מ כספית.
- ב. לחץ דם נמוך מ-130/80 מ"מ כספית.
- ג. לחץ דם נמוך מ-125/75 מ"מ כספית.
- ד. לחץ דם נמוך מ-120/70 מ"מ כספית.

42. בת 29, בריאה, ללא היסטוריה משפחתית של ממאירות בשד, וסתות סדירות. מתלוננת על כאב דו צדדי בשדיים (Mastalgia) מזה מספר שבועות. הכאב מחזורי (Cyclic). ממצאים תקינים בבדיקה גופנית.

כיצד יש לנהל את המקרה?

- א. להזמין את המטופלת לבדיקה ביום 14 למחזור.
- ב. להרגיע את המטופלת ולהמליץ על שימוש ב-NSAIDs.
- ג. המלצה לתזונה דלת Phytoestrogens (כגון טופו) סביב הוסת.
- ד. להפנות לסונר (US) שד בהקדם.

43. בת 32, בריאה. מזה שלושה שבועות מתלוננת על כאבים בגב תחתון, שהופיעו לאחר הרמת בנה התינוק. ללא הקלה לאחר טיפול ב-Ibuprofen (Ibuprofen). ללא אירועים דומים בעברה. שוללת חבלה, ללא הפרעות שליטה בסוגרים, ללא חום וללא ירידה במשקל.

בבדיקתה – רגישות Paravertebral מותנית במישוש מימין, והגבלה בתנועות הגב עקב כאבים. כיצד יש להתקדם בניהול המקרה?

- א. יש להפנות את המטופלת לבדיקת CT של עמוד שדרה.
- ב. לבצע בדיקות מעבדה – ספירת דם, בדיקת CRP.
- ג. יש לטפל במשככי כאבים ולעקוב אחר התסמינים.
- ד. יש להפנות את המטופלת לבצוע צילום עמוד שדרה מותני.

44. מה מאפיין את המהלך של רטינופטיה סוכרתית?

א. הרטינופטיה מתפתחת מהר יותר ובשכיחות גבוהה יותר בסוכרת Type 1 מאשר בסוכרת Type 2.

ב. במהלך הריון אצל חולת סוכרת נדיר שתפתח רטינופטיה, לאור הגנת השינויים ההורמונליים על העין.

ג. יעד איזון של $HbA1C < 7\%$ הוכח כמאט את התפתחות הרטינופטיה בסוכרת Type 2, אך לא בסוכרת Type 1.

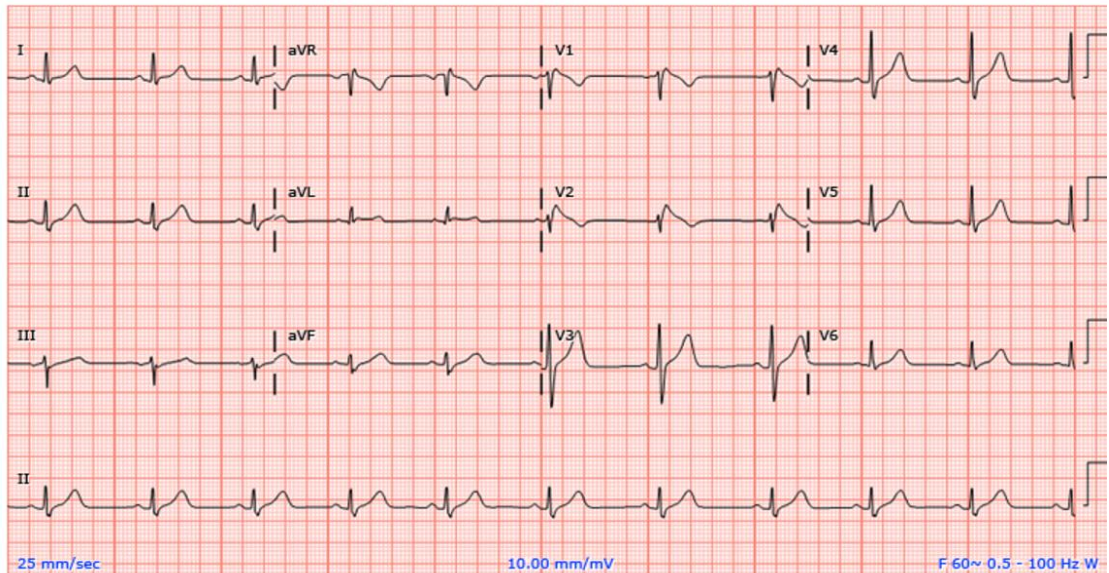
ד. לאחר עשר שנים של סוכרת Type 2, למרבית החולים תהיה רטינופטיה פרוליפרטיבית.

45. איזה מבין הטיפולים הבאים לתסמונת מעי רגיש (Irritable Bowel Syndrome) הוכח

מחקרית כיעיל?

- א. השתלת צואה.
- ב. Rifaximin (Lormyx) כטיפול קבוע.
- ג. היפנוזה.
- ד. פרוביוטיקה.

46. בן 23, בריא, בעברו אירוע של איבוד הכרה ללא טריגר ברור. הבוקר לאחר אמבטיה חמה הרגיש סחרחורת נפל ואיבד הכרה. התאושש לאחר דקות ספורות. שולל כאבים בחזה. לא ידוע על מחלות לב במשפחתו. בבדיקתו לחץ דם 130/84, האזנה ללב ולריאות תקינה בדיקה נוירולוגית תקינה. בתרשים אק"ג:



מה החשד הקליני הסביר ביותר?

- א. אירוע Vaso-Vagal.
- ב. תסמונת Brugada.
- ג. Hypertrophic Cardiomyopathy.
- ד. Hyperkalemia.

47. בת 40. אובחנה בגיל 21 כסובלת מסוכרת והחלה לקבל אינסולין בחשד שמדובר בסוכרת Type 1. למרות היענות טובה להנחיות הטיפול לא מצליחה להתאזן עם הטיפול באינסולין. לא ידוע על אירועי DKA בעברה, במשפחתה האח והדודה אובחנו כסובלים מסוכרת בגילאי 16-20. באיזה סוג סוכרת יש לחשוד?

- א. Type 2 Diabetes Mellitus.
- ב. Type 1 Diabetes Mellitus.
- ג. Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY).
- ד. Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA).

48. איזו הערכה נדרשת לילד בן 12 שאובחן עם הפרעת קשב וריכוז, לפני התחלת טיפול בסטימולנטים ומדוע?

- א. בדיקת TSH ונוגדני תירואיד לאור היפותירואידיזם אצל האם.
- ב. הערכה קרדיאלית לאור קרדיומיופתיה אצל האב.
- ג. בדיקת EEG לאור אבחנה של תסמונת טורט.
- ד. בדיקת סוכר בדם לאור סכרת הריונית אצל האם.

49. בן 70, ברקע Age-Related Macular Degenartion (AMD) ודלקת פרקים ראומטואידית. לאחרונה מתלונן על טשטוש ראייה.

בבדיקת עיניים נמצאו שינויים ברשתית.

איזו מהתרופות יכולה להסביר את מצבו?

- א. Methotrexate.
- ב. Adalimumab (Humira).
- ג. Hydroxychloroquine (Plaquenil).
- ד. Sulfasalazine (Salazopyrine).

50. בן 7, בריא בד"כ, מגיע למרפאה בשל הממצא הבא:



מהו החשד הקליני ומה הטיפול המומלץ?

- א. מצב הנובע משפשוף חוזר אין צורך בטיפול.
- ב. מדובר ב-Paronychia, דורש אנטיביוטיקה מקומית.
- ג. זיהום ב-Herpes Simplex, טיפול במשחת Acyclovir (Zovirax).
- ד. זיהום ב-Group A Streptococci, יש לנקז ולהתחיל אנטיביוטיקה פומית.

51. בן שנה וחצי, מזה 3 ימים עם חום גבוה מעל 39°C , חלש, יציאות מעט רכות מהרגיל. היום בבוקר כבר ללא חום, אולם הופיעה פריחה המתוארת בתמונה.



מי מהבאים הינו סיבוך אופייני למחלתו?

- א. הופעת פרכוסים.
- ב. Rheumatic Fever.
- ג. דלקת כבד חריפה.
- ד. Acute Orchitis.

52. בן 65, סובל מאי ספיקת לב כרונית עם $\text{EF}=35\%$. מטופל בחוסמי ביתא, מעכבי ACE ומשתנים, מתקשה עדיין בבצוע מאמצים.

איזה מבין הטיפולים הבאים מומלץ להוסיף לטיפולו הנוכחי?

- א. חוסמי תעלות סידן מקבוצת Non Dihydropyridine.
- ב. מעכבי SGLT2.
- ג. השתלת קוצב.
- ד. Entresto (Sacubitril-Valsartan).

53. בן 25, מאובחן כסובל מסכיזופרניה, מטופל ב-Zyprexa (Olanzapine) 5 מ"ג. אימו מדווחת שבימים האחרונים מסרב לקחת את תרופותיו. אינו ישן, צועק ודופק על דלתות השכנים בשעות הלילה, השליך חפצים מהמרפסת על העוברים ושבים. המטופל מסרב להגיע לבדיקה.

מה יהיה הצעד הבא בניהול המקרה?

א. פניה לפסיכיאטר מחוזי בבקשה להוצאת הוראת בדיקה כפויה דחופה לפי חוק טיפול בחולי נפש.

ב. העלאת מינון Zyprexa (Olanzapine) ל-10 מ"ג והתייעצות בהקדם עם פסיכיאטר מטפל.

ג. פניה לפסיכיאטר מחוזי בבקשה להוצאת הוראת בדיקה כפויה לא דחופה לפי חוק טיפול בחולי נפש.

ד. הפנייה דחופה לפסיכיאטר מחוזי של קופת חולים לצורך החלפת טיפול ל-Leponex (Clozapine).

54. מהן ההמלצות לגילוי מוקדם של סרטן שד בהעדר גורמי סיכון על פי המלצות "כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת"?

א. ממוגרפיה אחת לשנה בגילאי 50-75 לכלל אוכלוסיית הנשים.

ב. בדיקת שד ידנית עצמית מדי חצי שנה החל מגיל 30.

ג. בגילאי 50-75 יש לצרף לכל בדיקת הממוגרפיה בדיקת סונר (US) שדיים עקב סמיכות גבוהה של השד.

ד. בגילאי 40-49 אין התוויה גורפת לביצוע ממוגרפיה עקב שכיחות גבוהה של תוצאות חיוביות כוזבות.

55. ישי, בן 27, נשוי ואב לשני ילדים בני 2 ו-4 שנים. בעקבות תאונת דרכים נותר משותק בשתי רגליו ומתנייד בכיסא גלגלים. לפני התאונה היה המפרנס העיקרי ואשתו למדה לתואר שני. הוריו בגיל פרישה ומשתדלים לעזור ככל יכולתם בגידול הנכדים.

כיצד משפיעה התאונה על התמודדות המשפחה לפי מודל Rolland?

א. ישי ואשתו נמצאים בשלב צנטרפטלי של חיי המשפחה, בעקבות התאונה נאלצים להשקיע אנרגיות צנטריפוגליות.

ב. הוריו של ישי נמצאים בשלב הפרישה (הקן המתרוקן) ובעקבות התאונה נאלצים להשקיע אנרגיות צנטריפוגליות.

ג. ישי ואשתו נמצאים בשלב צנטריפוגלי. הצורך להשקיע יותר בבית יוצר מתח עקב אנרגיות צנטריפטליות רבות.

ד. ישי ואשתו נמצאים במצב צנטריפטלי, הקושי בתפקוד של ישי מוסיף כוחות צנטריפטלים נוספים.

56. בת 60, נמצאה בלוטה במוגדלת 2.2 ס"מ באזור Submandibular מימין. שוללת חום או הזעות לילה. ללא בלוטות לימפה מוגדלות באזורים אחרים. בוצעה בדיקת FNA מהבלוטה שהדגימה אזור נמקי עם שטפי דם ללא עדות לממאירות.

מה הצעד הבא המומלץ לבירור?

א. סרולוגיה ל-Toxoplasma ו-Brucellosis.

ב. השלמת Excisional Biopsy.

ג. טיפול אנטיביוטי אמפירי ב-Augmentin (Amoxicillin + Clavulanic Acid).

ד. טיפול ב-Prednisone לשבוע ימים.

57. בן 40, סובל מיתר לחץ דם עמיד לטיפול. בבדיקה נמצאו ערכים נמוכים של אשלגן בדם, ויחס אלדוסטרון לרנין (Aldosterone/Renin ratio) גבוה בשתי בדיקות.

כיצד יש להתקדם באישור האבחנה הסבירה ביותר?

א. מבחן Saline Infusion test בחשד ל-Primary hyperaldosteronism.

ב. מבחן דיכוי Dexamethasone בחשד ל-Cushing syndrome.

ג. מבחן דיכוי ACTH בחשד ל-Addison's Syndrome.

ד. Water Deprivation test בחשד ל-Diabetes Insipidus.

58. בת 30 סובלת מאסטמה, מטופלת במשאף Symbicort (Budesonide and Formeterol) 320/9 מק"ג פעמיים ביום. סובלת משיעול לילי, נעזרת ב- Ventolin (Salbutamol) 3 פעמים בשבוע וסובלת מקוצר נשימה במאמץ, אשר מגביל אותה בפעולות היום יום.
- בשנה אחרונה שתי החמרות, בהן טופלה בסטרואידים פומיים ואינהילציות של Ventolin (Salbutamol). מקפידה על הטיפול במשאף ומדגימה שימוש נכון במשאף.
- איזה מבין הממצאים הבאים יעלה חשד ל Type 2 inflammatory asthma?
- א. FeNO (Fractional exhaled nitric oxide) מופחת.
- ב. אאוזינופיליה בדם.
- ג. נויטרופילים בליחה.
- ד. חוסר תגובה לסטרואידים פומיים.
59. בן 45, משחק כדורסל להנאתו. מזה מספר שבועות מלין על כאב בכתף שמאל. שולל חבלה. הכאב מופיע בזמן נשיאת משקל בגפה זו ואף מפריע לשינה.
- מה התלונה שתחשיד ביותר לקרע בגיד ה-Supraspinatus?
- א. לא מסוגל להרים את היד ולהמשיך לשחק כדורסל.
- ב. לא מסוגל להניח יד על הבטן ולהרים את כף היד.
- ג. מתקשה להסתרק.
- ד. מלין על כאב במגע סביב פרק הכתף.
60. בן 15 שנים, בריא בד"כ ומחוסן לגילו. מתלונן על כאבי גרון מלווים בחום 38-39 וכאבי שרירים. בבדיקתו תפליטים בשקדים ולימפאדנופתיה צווארית רגישה. נלקחו משטח גרון ובדיקות דם, לאחריהן הותחל טיפול ב-Moxypen (Amoxicillin). כעבור יומיים מגיע הנער עם תפרחת עורית מקולופולארית מפושטת. משטח גרון תקין, בספירת דם לימפוציטים אטיפיים.
- מהי ההמלצה להמשך ניהול המקרה?
- א. לסיים 10 ימי טיפול ב-Moxypen (Amoxicillin).
- ב. החלפת טיפול אנטיביוטי ל-Azenil (Azithromycin).
- ג. הימנעות מפעילות גופנית מאומצת למשך 2-3 שבועות.
- ד. התחלת טיפול ארוך טווח בסטרואידים.

61. בת 3 שנים עם תפרחת עורית שורפת מזה 5 ימים. בבדיקתה הממצא הבא-



מהו הטיפול המתאים ביותר?

- א. שיכוך כאב וכיסוי הנגעים למניעת הדבקה.
- ב. ניקוז השלפוחיות.
- ג. Zovirax (Acyclovir) פומי למשך 5 ימים.
- ד. Moxypen (Amoxicillin) פומי למשך שבוע.

62. בת 26, ידוע על חסר של G6PD, וזיהומים חוזרים בדרכי השתן. כעת בשבוע 10 להריונה, מתלוננת על צריבה ותכיפות במתן שתן. ללא חום סיסטמי. בדיקה גופנית תקינה. בדיקת שתן בסטיק חיובית לכדוריות לבנות, אדומות וניטריטים.

מהו הטיפול המומלץ ביותר במצב זה?

- א. 960 mg Resprim (Trimethoprim Sulphamethoxazole) פעמיים ביום למשך שלושה ימים.
- ב. 500 mg Ciprodex (Ciprofloxacin) פעמיים ביום למשך 3 ימים.
- ג. 100 mg Macrochantin (Nitrofurantoin) שלוש פעמים ביום למשך 5 ימים.
- ד. 500 mg Zinnat (Cefuroxime) פעמיים ביום למשך 7 ימים.

63. נער בן 16 מגיע למרפאתך ביחד עם הוריו. מתלונן כי במהלך 3 החודשים האחרונים כמעט בכל לילה סובל מתחושות "מוזרות" ברגליים כגון עיקצוצים, נימולים ותחושה כמעט בלתי נשלטת להזיז את הרגליים. התופעה מאוד מקשה עליו להירדם בלילה.

מהן ההמלצות הטיפוליות למצב זה?

- א. הימנעות מחומרים מעוררים המכילים קפאין.
- ב. מתן תוספי ויטמין B12 למשך מספר חודשים.
- ג. במצב קשה, יש לשקול שימוש באנטגוניסטים לדופמין.
- ד. תוסף מגנזיום בשילוב עם ויטמין E ו-B6 עשוי להועיל במצב זה.

64. במהלך התקף פאניקה- איזה מבין התסמינים הבאים יחייב המשך בירור?

- א. תחושת נימול.
- ב. בריחת שתן.
- ג. צמרמורת.
- ד. קוצר נשימה.

65. בת 28, בריאה, 3 חודשים לאחר לידה ראשונה, הנקה מלאה. מלינה על אודם וכאב בשד ימין מזה כיממה, ללא קושי להניק. ללא חום סיסטמי. בבדיקתה, מצב כללי טוב, שדיים ללא גודש, לא נימושו גושים. אודם, חום מקומי ורגישות במישוש, ראה תמונה.



מה הטיפול המתאים בשלב הנוכחי?

- א. הפסקת הנקה עד היעלמות התסמינים.
- ב. טיפול ב-500 Ceforal (Cephalexin) מ"ג ארבע פעמים ביום, למשך 10 ימים.
- ג. המשך הנקה וטיפול בנוגד דלקת, כמו Advil (Ibuprofen).
- ד. משחה אנטי-פטרייתית לאחר כל הנקה, למשך 10-14 ימים.

66. משפחה מתכננת לנסוע למדינה בה יש התפרצות חצבת. התינוק בן 7 חודשים ולא חוסן עדיין נגד חצבת.

מהי ההמלצה לגבי חיסון הילד?

- א. מומלץ מתן חיסון סביל כי לא ניתן לחסן בחיסון MMR.
- ב. ניתן לחסן כעת בחיסון MMR אך מנה זו לא תיספר כחלק מחיסוני השגרה.
- ג. ניתן לחסן כעת בחיסון ה-MMR במקום המנה של גיל שנה.
- ד. לא ניתן לחסן בחיסון MMR. במידה ויפתח תסמינים יקבל IVIG.

67. איזו המלצה נכונה לכל תינוק בישראל על סמך הנחיות קידום בריאות ורפואה מונעת בישראל?

- א. צחצוח שיני הילד מדי יום החל מבקיעת השן הראשונה.
- ב. מתן ברזל במינון 7 מ"ג מהלידה ועד גיל 18 חודשים.
- ג. בדיקת רופא ילדים אחת לשלושה חודשים בשנה הראשונה.
- ד. בדיקת סינון לליקוי שמיעה בגיל 7-9 חודשים.

68. מה מאפיין טיפול ב-Levodopa בחולי פרקינסון?

- א. במחצית מהמטופלים ירידה ביעילות הטיפול תוך שנתיים.
- ב. פחות תופעות לוואי בהשוואה לטיפול באגוניסטים לדופמין, כדוגמת Requip (Ropinirol).
- ג. התחלת טיפול ב-Levodopa בסמוך לאבחנה מעכבת את התקדמות המחלה.
- ד. במטופלים שגילם פחות מ-65 מומלץ להתחיל טיפול ב-Levodopa כקו ראשון לטיפול התסמינים.

69. בת 53, פנתה עקב מדידת ל"ד מוגברת בבית מלווה בסחרחורת, שתי הקאות וטשטוש ראייה. בבדיקה- בהכרה מלאה, ל"ד 190/130 ללא סימני צד. ידוע על יתר לחץ דם מאוזן עם Tritace Comp (Ramipril + Hydrochlorothiazide). לאחרונה החלה טיפול במדבקות Evorel (Estradiol patch) עקב תסמיני גיל המעבר. כיצד יש להמשיך בניהול המקרה?
- א. הפניה למיון להמשך טיפול תוך ורידי להורדת לחץ הדם.
ב. Captopril תת לשוני, המשך מעקב ביתי וחזרה למעקב מרפאתי בעוד 24 שעות.
ג. כדור Tritace Comp (Ramipril + Hydrochlorothiazide) נוסף כעת ולאחר מכן השגחה במרפאה עד שלחץ הדם יורד מתחת ל-180/100.
ד. נטילת Tritace Comp (Ramipril + Hydrochlorothiazide) נוסף כעת, הפסקה של טיפול מדבקות אסטרוגן, וחזרה לבדיקה במרפאה למחרת לאיזון מיטבי והתאמת תרופות.
70. בן 67, מזה כ-20 דקות לא רואה כלל בעין ימין. שולל חבלה או כאב בעין, או תסמינים סיסטמיים. במיון אובחן Central Retinal Artery Occlusion. פרט למעקב רופא עיניים, מה הבירור הנדרש כעת?
- א. בדיקת לחץ תוך עיני וחדות ראייה.
ב. בדיקות אק"ג, אקו לב, סונר קרוטידים.
ג. בדיקת JAK2.
ד. בירור קרישיות יתר.
71. בן 40, בריא, מתלונן על חום 38.5°C מזה שבועיים, מלווה בחולשה כללית. בבדיקתו- חום 38.7°C פומי, לחץ דם 125/80, דופק 54. טחול מוגדל, כבד נימוש תקין. מה יהיה הצעד הבא בבירור הראשוני?
- א. Calprotectin בצואה בשאלת IBD.
ב. סרולוגיה למונוקלאוזיס-EBV ו-CMV.
ג. PET-CT בשאלת לימפומה.
ד. Transesophageal Echocardiogram.

72. בת 50, אחות במקצועה, BMI 30. פנתה להתייעצות לגבי אפשרות למניעת דורבן (Plantar Fasciitis).

מהי ההמלצה הנכונה ביותר לצמצום הסיכון?

א. להתחיל אימוני ריצה.

ב. לבצע תנועות פלנטריות של הקרסול.

ג. לעשות אמבטיות חמות לרגליים.

ד. לרדת במשקל.

73. בן 58 פונה עקב ירידה בשמיעה. שולל חבלה, סחרחורת, כאבים או חשיפה לרעש.

איזה מבין הממצאים הבאים מהווה סיבה להמשך בירור?

א. בבדיקתו נראה צרומן רב בתעלות.

ב. נצפו נוזלים מאחורי התופית, יותר בצד ימין.

ג. נרשמה ירידה דו צדדית של 25 דציבל בתדרים הגבוהים ללא הבדל בין הולכת אוויר ועצם.

ד. נצפה פער של 20 דציבל לרעת אוזן ימין ללא הבדל בין הולכת אוויר ועצם.

74. בן 5 בריא ומחוסן בהתאם לגילו, משתעל מזה 3 שבועות. בחשד לשעלת, מהי בדיקת

הבחירה לאישוש האבחנה?

א. רמה גבוהה של לימפוציטים בדם.

ב. אימונוגלובולינים מסוג IgA בדם.

ג. PCR ללוע העליון (Nasopharynx).

ד. תרבית מהלוע.

75. מה מהבאים מומלץ לבירור אירוע ראשון של Venous Thromboembolism (VTE)?

א. יש לבצע בירור מעבדתי לקרישיות יתר לאחר כל אירוע של Provoked VTE.

ב. מומלץ לבצע CT חזה בטן ואגן כחלק מבירור ממאירות לאחר כל אירוע של Unprovoked VTE.

ג. טיפול בנוגדי קרישה עלול להטות תוצאות של בירור מעבדתי לקרישיות יתר.

ד. ביצוע בירור מעבדתי לקרישיות יתר מולדת צריך להתבצע סמוך ככל הניתן לאירוע.

76. בת 28, סובלת מגרד ממושך בידים ורגליים, נגעים הבאים באזור המרפקים:



ניסיון טיפול בשימון מקומי ומשחה סטרואידלית לא היטיבו את המצב.

מה מומלץ לגבי הטיפול המתקדם המתאים לה?

א. שימוש מקומי ב-Calcineurin Inhibitors (Tacrolimus) אסור לשימוש במקביל לסטרואידים מקומיים.

ב. ניתן לטפל בפוטותרפיה מסוג Narrowband UVB (NB-UVB).

ג. טיפול באנטיביוטיקה סיסטמית מניעתית.

ד. מומלץ טיפול קבוע באנטיהיסטמין דור שני להקלת הגרד.

77. בת 38, נ + 1, בריאה בד"כ. מלינה על עייפות, כאבי ראש, עצבנות, קושי בריכוז ועצבות,

שנמשכים כשבוע מידי חודש לפני הוסת.

מהו הטיפול היעיל ביותר למצבה?

א. Sertraline (Lustral).

ב. Clonex (Clonazepam).

ג. Combined Oral Contraceptive.

ד. Pyridoxine (Vitamin B6).

78. בבירור מטבולי של אבנים בדרכי השתן אובחנה אבן מסוג Struvite (Magnesium Ammonium Phosphate).

מה ההמלצה הטיפולית למניעת הישנות?

א. Alloril (Allopurinol).

ב. Ascorbic Acid.

ג. Potassium magnesium citrate.

ד. Penicillamine.

79. בן 70, בריא בדרכ"כ, חקלאי במקצועו. פונה עקב הנגע הבא על פני שוק ימין, שהופיע לפני חצי שנה וגדל לאחרונה.



מה נכון לגבי התפתחות הנגע?

א. ברוב המקרים נגע זה מתפתח מ-Seborrheic Keratosis.

ב. הנגע מופיע בעיקר בגברים לבנים בכפות ידיים ורגליים.

ג. Congenital nevi בקוטר של 0.5 ס"מ מהווה גורם סיכון להופעת נגע זה.

ד. הנגע נוטה לצמוח שטחית ובהמשך לעומק.

80. בן 70, לאחרונה בעקבות ירידה בראיה אובחן כסובל מגלאוקומה.

מהו ההסבר לגבי האפשרויות הטיפוליות?

א. טיפול ב- Selective Laser Trabeculoplasty פחות יעיל לשימור שדה הראייה מטיפול מקומי בטיפות.

ב. טיפות (Brimonidine) Alphagan יכולות לגרום ליובש בפה.

ג. מומלץ להמתין עם התחלת טיפול במקרה של Normal tension glaucoma.

ד. יש להתחיל טיפול מיד עם קבלת האבחנה של לחץ תוך עיני מוגבר, גם בהעדר Cupping של עצב הראייה.

81. בן 63, בריא בד"כ, נבדק אתמול במיון בשל אצירת שתן. בחדר מיון הוכנס קטטר, נמצאה

שארית שתן של 700 סמ"ק. החל טיפול ב-Omnice (Tamsulosin) והופנה להמשך בירור בקהילה.

מה יש להסביר למטופל לגבי מצבו?

א. ניתן לבצע ניסיון גמילה מקטטר שתן החל מהיממה השלישית להכנסתו.

ב. שארית שתן של 150 מ"ל לאחר ניסיון גמילה מקטטר מהווה אינדיקציה להחזרתו.

ג. החלפת הטיפול ל-Avodart (Dutasteride) תשפר את סיכויי הגמילה מהקטטר.

ד. בימים הראשונים צפויה התמעטות בכמות השתן בקטטר.

82. מה נכון לגבי הגישה לריבוי תרופות בקשישים?

א. Beers Criteria הינה רשימת תרופות המועדפות בגיל השלישי.

ב. ריבוי יועצים מבטיח דיוק באבחנה וצמצום טיפולים מיותרים.

ג. ההגדרה של Polypharmacy היא שימוש קבוע בחמש תרופות או יותר.

ד. מערכת ממוחשבת לחידוש תרופות אוטומטי מהווה גורם מגן מפני ריבוי תרופות.

83. בת 8 מתלוננת על תפרחת שהופיעה לפני 3 ימים, מלווה בכאבי מפרקים, כאבי ראש, כאבי בטן ושלשול.
בבדיקתה הממצא הבא-



איזה מבין הממצאים הבאים סביר שיימצא בבדיקתה?

א. תפליטים דו"צ על גבי השקדים.

ב. הארכת מקטע PR באק"ג.

ג. המטוריה.

ד. Sydenham chorea.

84. בן 16 מתלונן שמזה חודש ימים סובל משיעול וקוצר נשימה הולך ומתגבר. ברקע משתמש בסיגריות אלקטרוניות ומכשירי אידוי (Vaping) בטעמים שונים.

איזה מבין המצבים הבאים יחזק חשד לפגיעה ריאתית עקב שימוש במכשיר אידוי

?EVALI (E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury)

א. ברונקיאקטזיות בבדיקת CT של הריאה.

ב. שינויים רסטריקטיביים בתפקודי ריאות.

ג. סמנים ל-Perihilar lymphadenopathy דו צדדית בצילום חזה.

ד. דיפוזיה CO תקינה בבדיקת ספירומטריה.

85. בן שלושה שבועות, בכור להוריו, לאחר הריון ולידה תקינים, בריא עד כה. האם מודאגת מכיוון שהבחינה כי ראשו נוטה לצד אחד. בבדיקתו על גבי שריר ה-Sternocleidomastoid מימין נמוש ממצא נוקשה מעט.

מהי ההמלצה המתאימה ביותר?

- א. יש לבצע בירור הדמייתי טרם התחלת טיפול כלשהו.
- ב. מומלצת פיזיותרפיה לתרגול מתיחות של שריר ה-Sternocleidomastoid.
- ג. זהו מצב שפיר החולף מעצמו ואין צורך בטיפול או בירור נוסף.
- ד. יש לנתח לשחרור שריר ה-Sternocleidomastoid.

86. בת 65 ברקע סרטן ריאות גרורתי. סובלת ממצב רוח ירוד, אנהדוניה, וקשיי שינה, ללא מחשבות אובדניות. בנוסף, סובלת מכאב שורף בבית החזה בפיזור רדיקולרי.

מה הטיפול המתאים ביותר למצבה?

- א. Methadone (Methadone).
- ב. Pregabalin (Lyrica).
- ג. Escitalopram (Ciprallex).
- ד. Duloxetine (Cymbalta).

87. בן 60, ברקע סכרת. מבצע מעקב בשיטת Continuous Glucose Monitoring. מהו יעד האיזון הרצוי עבורו?

- א. מעל 70% מהמידות הן בטווח 70-180 mg/dL.
- ב. מעל 70% מהמידות הן בטווח 100-130 mg/dL.
- ג. מתחת ל-10% מהמידות הן בטווח 54-69 mg/dL.
- ד. מתחת ל-10% מהמידות נמוכות מ-69 mg/dL.

88. בת 35, בבירור של אל-ווסת משנית (Secondary Amenorrhea) אובחנה Prolactinoma בהיפופיזה. הוחל טיפול ב-Dostinex (Cabergoline).

מהי השפעות הטיפול?

- א. הסיכון לאי ספיקת מסתם מיטרלי עולה כבר בתחילת הטיפול.
- ב. הטיפול ב-Dostinex מפחית סיכון לפסיכוזה חריפה.
- ג. הטיפול ניתן לכל החיים ללא קשר לאיזון רמת הפרולקטין.
- ד. ה-Prolactinoma יכולה לעבור רגרסיה תחת הטיפול ב-Dostinex.

89. בת 74, ברקע מעשנת כבדה, מאובחנת עם סכרת. אובחנה לאחרונה עם מחלת כלי דם פריפרית.
- באיזה מבין המצבים הבאים סיכוי טוב יותר להצלחת צנתור עורקים?
- א. טרשת עורקים בכלי דם הקטנים.
 - ב. היצרות של העורק לאורך יותר מ-10 ס"מ.
 - ג. היצרות בעורק פרוקסימלי גדול.
 - ד. היצרויות קצרות מרובות לאורך העורק.
90. בת 20 מתלוננת על אירועים חוזרים של שינויי צבע (חיוורון, כחלון ואחר כך אודם) באצבעות הידיים מלווה בכאב.
- איזה מבין המצבים הבאים יצדיק בירור למחלת רקע כגורם לתופעה?
- א. האישה מעשנת.
 - ב. סובלת מהתקפי מיגרנה.
 - ג. מעורבות של האגודלים.
 - ד. Livedo Reticularis עורי.
91. בת 16, סובלת מהתקפי מיגרנה עם Aura. מעוניינת להתחיל ליטול אמצעי מניעה.
- מהי ההמלצה המתאימה ביותר עבורה?
- א. גלולות משולבות אסטרון + פרוגסטרון.
 - ב. התקן תוך רחמי מפריש פרוגסטרון לדוגמא (Mirena (levonorgestrel).
 - ג. זריקות (Depo-Provera (Medroxy Progesterone acetate אחת לחצי שנה.
 - ד. שימוש ב Trans Dermal Patch דוגמת (Evra (Norelgestrimin + Ethinyl.
92. בן 30, מזה שנה מלין על כאב גב תחתון. בעברו אירוע Uveitis בעין שמאל.
- מספר שאביו גם סבל מכאבי גב מגיל צעיר.
- בבדיקתו הגבלה בכיפוף הגב התחתון וכן איוושה דיאסטולית בגבול עצם חזה שמאלי (LSB).
- איזה מבין המצבים הבאים צפוי להיות הסתמנות נוספת של מחלתו?
- א. כאב והגבלה בתנועות הצוואר.
 - ב. הגבלה בהתפשטות בית החזה בשאיפה.
 - ג. כאב בכפות הידיים והרגליים.
 - ד. כאב הגב מוחמר במאמץ ומוקל במנוחה.

93. בת 30, בריאה בד"כ, 3 ימים חום. פנתה בשל חולשה וצהבת מהיום.

במעבדה:

נורמה	ערך	
12-16	9.4	Hemoglobin (g/dL)
80-100	95	MCV (fl)
0.2-0.8	3.5	Indirect Bilirubin (mg/dL)
140-280	370	LDH (U/L)
29-33	45	ALT (IU/L)
10-36	55	AST (U/L)
0.5-2.5	3	Reticulocyte (2%)

מה האבחנה הסבירה ביותר?

- א. Gilbert's Syndrome.
- ב. Cholelithiasis.
- ג. G6PD Deficiency.
- ד. Acute Hepatitis B.

94. בת 71, מטופלת ב-Coumadin (Warfarin) על רקע פרפור עליות חדש והיצרות מסתם

מיטרלי על רקע ראומטי. כמו כן אירועים חוזרים של Urinary Tract Infection.

כיצד יש להדריך את המטופלת לגבי השימוש ב-Coumadin ?

- א. בעת אירוע של דלקת בשתן יש להימנע ממנת (Nitrofurantoin) Macrochantin.
- ב. יש להימנע מאכילת ירקות עליים ירוקים.
- ג. עד התייצבות INR יש לבצע מעקב מעבדתי פעמיים בשבוע.
- ד. זמן הנטילה המומלץ הוא לאחר ארוחת בוקר.

95. באיזה מבין המצבים הבאים יש לבצע בדיקת צפיפות עצם בטרם הגיל המומלץ באוכלוסייה

הכללית?

- א. BMI גבוה מ-35.
- ב. שבר בעצם הבריח.
- ג. טיפול בסטרואידים למשך חודש.
- ד. מיאלומה נפוצה (Multiple Myeloma).

96. מה יש להסביר בנוגע לטיפול הורמונלי חליפי להקלה על תסמיני גיל המעבר?
- א. תכשיר אסטרוגן סיסטמי מהווה טיפול בחירה למניעת דלקות בשתן ודיספראוניה.
 - ב. תכשיר משולב אסטרוגן ופרוגסטין יעיל למניעת גלי חום.
 - ג. תכשיר משולב אסטרוגן ופרוגסטין מעלה סיכון לסרטן רירית רחם.
 - ד. תכשיר אסטרוגן סיסטמי מוריד את הסיכון לאבנים בדרכי מרה.
97. על איזה מבין השיקולים הבאים יש להסתמך בבחירת הטיפול לדיסליפידמיה על מנת להפחית תחלואה ותמותה קרדיווסקולרית?
- א. במטופלים בסיכון גבוה וגבוה-מאוד יש להתחיל טיפול בסטטין בעצימות גבוהה במינון מקסימלי נסבל.
 - ב. טיפול ב-Ezetimib (Ezetrol) בלבד הביא להפחתה קטנה אך מובהקת סטטיסטית.
 - ג. הטיפול במעכבי PCSK9 יעיל יותר במטופלים עם סיכון קרדיווסקולרי נמוך.
 - ד. לחומצה ניקוטינית (ניאצין) יתרון קליני כאשר הטיפול ניתן בשילוב עם סטטין.
98. בן 74, מהנדס בגמלאות, ברקע יתר לחץ דם וסכרת מאוזנת. מתלונן על ירידה בזיכרון מזה כחצי שנה. שוכח שמות של אנשים מוכרים, לעיתים חוזר על משפטים. שוכח היכן הניח חפצים. מודאג מאוד ממצבו. לאחר בדיקה נוירולוגית והערכה קוגניטיבית רושם ל-Mild Cognitive impairment. מהי ההמלצה המתאימה למצבו?
- א. להתחיל טיפול במעכבי Acetylcholinesterase.
 - ב. עקב סיכון מוגבר להתקדמות לדמנציה על המטופל להקפיד על תזונה ים תיכונית.
 - ג. יש להשלים בדיקת PET Amyloid על מנת לבסס את האבחנה.
 - ד. טיפול מוקדם ב-Ginkgo biloba יכול להאט את התקדמות המחלה לדמנציה.
99. בן 65, מלין על כאב גב מזה חודש וחצי.
- איזו תלונה תכוון לאבחנה של היצרות ספינלית לומברית ולא למחלת דיסק רדיקולרית?
- א. כאב הגב החמיר לאחר הרמת ארגז כבד בבית.
 - ב. הכאב מקרין עד מתחת לברך.
 - ג. הכאב הופיע בשתי הרגליים במקביל בזמן הליכה.
 - ד. הכאב החמיר לאחר התעטשות או שיעול.

100. נבדק תכשיר חדש לטיפול תרופתי להקלה על שיעול במחלה רספירטורית ויראלית. מתוך 100 נבדקים בקבוצת הביקורת, דווחו 20 מקרים של נזק מטיפול ה-PLACEBO. מתוך 100 נבדקים בקבוצת המחקר, דווחו 25 מקרים של נזק מנטילת התרופה החדשה.

מהו ה-NNH במחקר זה?

- א. 5.
- ב. 20.
- ג. 25.
- ד. 100.

101. בן 27, מגיע לפגישת היכרות במרפאתך. במהלך הפגישה משתף שמקיים יחסי מין מזדמנים עם גברים, ללא שימוש באמצעי מניעה. בהתאם להנחיות קליניות לרפואה מונעת באוכלוסיית הלהט"ב מהי ההמלצה הנכונה עבורו?
א. חיסון לעגבת (Syphilis) ומתן PEP.
ב. בדיקת דם ל-HBV, HCV, HIV ומתן PREP.
ג. בדיקת דם לכלמידיה (Chlamydia) וזיבה (Gonorrhea).
ד. מתן חיסון לעגבת ו-Human Papilloma Virus.

102. את מי מהמטופל הבא מומלץ להפנות לבדיקת דם לבירור צליאק- Anti Tissue Transglutaminase antibodies (Anti TTG)?
א. בן 45, BMI 32, גלוקוז בצום 140.
ב. בת 36 עם אדנומה של ה-Parathyroid.
ג. בת 29, צמחונית עם Vitamin B12 נמוך.
ד. בן 35, שבר דחיסה בעמוד שדרה.

103. איזו מבין התופעות הבאות היא תופעה חוץ מפרקית של Rheumatoid Arthritis?
א. Glaucoma.
ב. Obstructive Lung Disease.
ג. Splenomegaly.
ד. Mitral Stenosis.

104. בן 60, מעשן כבד ושותה אלכוהול בכמות רבה, מגיע למרפאה עם תלונה על נגע ברירית בפה בלחי ימין, ללא כאבים, שלא מחלים מזה 3 שבועות. בבדיקה נצפה תלאי (Patch) אדמדם ברירית הפה בלחי ימין (buccal mucosa), ללא נגעים נוספים בפה או בשפתיים.

מה הצעד הבא בניהול המקרה?

- א. השלמת ביופסיה מהנגע בהקדם.
- ב. מעקב קליני לאור סיכון נמוך לממאירות.
- ג. משחת Oracort (Triamcinolone Acetonide) לשבוע.
- ד. הפסקת עישון ושתייט אלכוהול ומעקב בעוד חודש.

105. כל המטופלים הבאים סובלים מירידה בליבידו ומקשיים בהגעה לזקפה. בבדיקות דם נמצאו ערכי טסטוסטרון כולל נמוך מ-10.5 nmol/l (300 ng/dl) בשתי פעמים נפרדות. במי מהמטופלים אפשר לטפל בטסטוסטרון בשלב זה?

- א. בן 48, במעבדה - רמת פרולקטין מוגברת.
- ב. בן 55, ברקע - תסמונת APLA.
- ג. בן 38 שמעוניין בפריון עתידי.
- ד. בן 54, שנה לאחר אוטם שריר הלב, ללא תסמונת תעוקתית.

106. למי מהמטופלים הבאים יש לבצע ניקור פלאורלי?

- א. בן 70 ברקע אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד 35% לפי אקו לב. מתלונן על קוצר נשימה, בצילום חזה נוזל פלאורלי בכמות בינונית דו צדדי.
- ב. בן 60 ברקע שחמת כבד על רקע מחלת כבד אלכוהולית. מתלונן על קוצר נשימה ונפיחות בבטן. בצילום חזה נוזל פלאורלי דו צדדי בכמות קטנה.
- ג. בן 50 ברקע אי ספיקת כליות על רקע מחלת כליות פוליציסטית. בצילום חזה אלקטיבי לקראת ניתוח בקע נוזל פלאורלי בכמות קטנה דו צדדי.
- ד. בן 60 ברקע אי ספיקת כליות על רקע נפרופתיה סכרתית. מתלונן על חום וכאבים פלאוריטים דו צדדיים. בצילום חזה נוזל פלאורלי בכמות קטנה משמאל וכמות בינונית מימין.

107. בת 36, ביצעה בדיקות דם שגרתיות.

	Value (mg/dL)
Glucose	92
Total Cholesterol	187
Cholesterol -LDL	65
Cholesterol -HDL	58
Triglycerides	320

כיצד נכון לנהל את המקרה?

- א. Bezalip (Bezafibrate) פעם ביום.
- ב. בדיקת דם לפרופיל ליפידים אחת לחמש שנים.
- ג. Omacor (Omega 3) פעמיים ביום.
- ד. המשך בירור סיבות משניות ושינוי אורחות חיים.

108. בת 25, מופנית לחדר מיון בחשד ל-Acute Appendicitis. חוששת מניתוח והוסבר לה

שיש אפשרות לשקול טיפול שמרני.

מהם השיקולים בבחירת אפשרויות הטיפול?

- א. בגישה שמרנית ניצול ימי המחלה וטיפולים אנלגטיים יותר גבוה.
- ב. בטיפול שמרני שכיחות יתר לסיבוכים.
- ג. יש לשקול גישה שמרנית במבוגרים אך לא בילדים.
- ד. פחות ממחצית המקרים שטופלו שמרנית יצטרכו ניתוח בשנה הקרובה.

109. בן 65, מקבל טיפול ב-Tritace (Ramipril) 5 mg/day, ממוצע מדידות לחץ הדם 130/80. בבדיקות המעבדה נמדדו ערכים המתאימים לפינוי קריאטינין מחושב (eGFR) בין 50-60 מל/דקה/שטח גוף למשך 6 חודשים רצופים.
- יח Albumin/Creatinin בשתן מתחת ל- 30 מג/גרם.
- ערכי נתן ואשלגן תקינים, פרופיל השומנים מראה LDL בערך מחושב של 120mg/dL. בספירת הדם המוגלובין 11g/dL עם אינדקסים נורמוציטים נורמוכרומיים.
- מהן ההמלצות הטיפוליות לגבי המשך ניהול המקרה?
- א. התחלת טיפול ב-Recombinant Human Erythropoietin.
- ב. הפסקת טיפול במעכבי ACE ומעבר לחוסמי תעלות סידן.
- ג. התחלת טיפול בסטטינים.
- ד. הוספת טיפול משתן ב-Fusid (Furosemide).
110. בת 62, מתלוננת בשבועיים האחרונים על אירועים חוזרים של סחרחורת. הסחרחורת סיבובית, מופיעה בשכיבה על הצד ונמשכת דקות בודדות.
- איזו בדיקה תכנון לאבחנה הסבירה ביותר?
- א. ROMBERG TEST.
- ב. Test of Skew.
- ג. Dix-Hallpike maneuver.
- ד. Brain Evoked Response Auditory (BERA).
111. את/ה מעוניין/ת לתכנן מחקר שבודק את הקשר בין החשיפה למי שתיה לא רתוחים ותחלואה גסטרואינטסטינלית.
- איזה מבין הבאים יהיה יתרון למחקר cross sectional במקרה זה?
- א. הסיכוי להטיות במחקר מסוג זה קטן ביותר.
- ב. המחקר מהיר ומספק קשר סיבתי בין החשיפה (שתית מיים לא רתוחים) לתוצאה (תחלואה גסטרואינטסטינלית).
- ג. המחקר מאפשר לקבל Odds Ratio – בין הסיכוי לחשיפה למי שתיה לא רתוחים בקרב מקרי התחלואה הגסטרואינטסטינלית, לבין הסיכוי לחשיפה למי שתיה לא רתוחים בקרב הבריאים.
- ד. המחקר מאפשר לקבל Relative Risk – הסיכון היחסי לתחלואה גסטרואינטסטינלית בקרב אילו השותים מי שתיה לא רתוחים לעומת אילו השותים מי שתיה רתוחים.

112. מי מהמטופלים מקבל טיפול מותאם עבורו בנוגדי קרישה?
- א. בן 55, לאחר ניתוח להחלפת ברך פיתח DVT בחלק דיסטלי של שוק ימין. יש לטפל ב- NOAC (New Oral Anticoagulants) למשך 6 חודשים.
- ב. בת 37, 4 ימים לאחר תאונת דרכים. אנמיה עקב דימום לאחר התאונה. פיתחה Proximal DVT בירך ימין. יש לטפל ב- NOAC למשך 6 חודשים.
- ג. בן 80, לפני כחודשיים עבר החלפת מפרק ירך שמאל, לאחריה פיתח תסחיף ריאתי. יש לטפל ב- NOAC למשך 6 חודשים.
- ד. בת 22, פיתחה DVT בשבוע 30 להריון בשוק שמאל, מטופלת באנטיקוגולציה. התקבלה לחדר לידה בשבוע 42. יש להאריך את הטיפול למשך 6 שבועות עד תום משכב הלידה.
113. בת 70, ברקע - אוטם שריר הלב לפני 6 חודשים ויתר לחץ דם. מזה שנתיים מטופלת ב- Ribone (Risedronate). כעת שוחררה משיקום בשל שבר צוואר הירך. מהו הטיפול המתאים במטופלת זו?
- א. Aclasta (Zoledronic Acid).
- ב. Evista (Raloxifene).
- ג. Forteo (Teriparatide).
- ד. Evenity (Romosozumab).
114. איזה מבין המצבים הבאים תומך באבחנה של Polymyalgia Rheumatica (PMR)?
- א. אנמיה מאקרוציטית מלווה בטרומבוציטופניה.
- ב. Subdeltoid Bursitis בבדיקת סונר של הכתפיים.
- ג. ערכי CPK מוגברים מעל פי 5 מהנורמה.
- ד. בבדיקות המעבדה בדיקת ANA חיובית.

115. בן 48 בריא בד"כ, עובד במחשבים. מזה שבועיים מתלונן על כאב באזור מרפק שמאל, מחמיר בפעולות כמו הרמה של תיק המחשב, מזיגת שתיה, פתיחה של צנצנת. שולל חבלה לאזור המרפק. בבדיקתו תנועת מרפק תקינה, ללא אודם ללא נפיחות באזור. רגישות נקודתית על גבי מוצא ה- Extensor Carpi Radialis Brevis. מבחן הרמת כסא חיובי.

בהתאם לנתונים אלו, מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. Medial Epicondylitis.
- ב. Olecranon Bursitis.
- ג. Lateral Epicondylitis.
- ד. Nerve Entrapment Syndrome.

116. בת 82, התאלמנה לפני שנה ומאז סובלת מהפרעות שינה שמתבטאות בקושי להירדם ומיקיצות לילה מרובות. שוחחתם על כך בעבר- שוללת דיכאון ומקפידה על היגיינת שינה, וכעת מעוניינת בטיפול תרופתי.

איזו מבין התרופות הבאות היא המתאימה לה ביותר?

- א. Bondormin (Brotizolam).
- ב. Nocturno (Zopiclone).
- ג. Gillex (Doxepin).
- ד. Seroquel (Quetiapine).

117. ניסוי שבדק השפעתה של תרופה חדשה חילק 100 חולים באופן אקראי ל-2 קבוצות- טיפול ופלצבו. במהלך הניסוי נפטרו 10 מטופלים בקבוצה שלקחה את התרופה לעומת 20 בקבוצת הפלצבו.

מה מהבאים נכון?

- א. צריך לטפל בחמישה חולים כדי למנוע מקרה מוות אחד.
- ב. הסיכון היחסי לאירוע מוות בקבוצה המטופלת לעומת פלצבו הוא 20%.
- ג. הפחתת הסיכון המוחלטת בין שתי הקבוצות היא 50%.
- ד. אם ה- $P \text{ value} \leq 0.05$ ניתן להגיד בוודאות שהטיפול יעיל.

118. בן 25, נשוי, בחודשים האחרונים עליה במשקל וירידה בתפקוד מיני, ללא ירידה בליבידו. מצב רוח תקין. אין זיקפת בוקר.

איזו פעולה אבחנתית תוביל בסבירות הגבוהה ביותר לטיפול הנכון?

א. הערכה של יחסים זוגיים.

ב. הערכה פסיכולוגית אישית.

ג. השלמת פרופיל הורמונלי.

ד. השלמת ספירת זרע.

119. בן 70, סובל מסרטן ריאות גרורתי, הוגדר בשלב סופי. מעברו MI, מטופל ב-Lipitor (Atorvastatin) ו-Cartia (Aspirin). אשתו מטפלת בו במסירות. נמצא בביתו, מעורפל הכרה, מסרב לשתות ולאכול. בהנחיות מקדימות שמילא מבקש להימנע מפעולות מאריכות חיים. אשתו מבקשת לעשות הכל על מנת להצילו.

מה יש לעשות על פי חוק החולה הנוטה למות?

א. במצב חירום רפואי יש לבצע החייאה.

ב. אין להימנע ממתן טיפול בנוזלים.

ג. יש לטפל אנטיביוטית בעת דלקת ריאות.

ד. אין להפסיק טיפול ב-Lipitor ו-Aspirin.

120. בת 30, בריאה בד"כ, כעת בהיריון שבוע 25. ביצעה בדיקת העמסת סוכר של 50 גרם לא בצום עם תוצאה של 150 מ"ג/ד"ל.

מה יכלול המשך בירור המקרה?

א. זו תוצאת העמסת סוכר תקינה בשלב היריון זה, ללא צורך בהמשך בירור.

ב. יש לבצע העמסת סוכר חוזרת של 50 גרם בצום.

ג. יש להשלים העמסת סוכר של 100 גרם.

ד. זו העמסת סוכר אבחנתית לסוכרת היריון, אין צורך בהמשך בירור.

121. אמא לילדים מתעניינת במתן חיסון שפעת עונתי לילדיה ובסוגי החיסון הקיימים.
בנה בן ה-10 חוסן לפני 3 שנים. הבת, בת 6 שנים, חוסנה לפני שנתיים.
מהו ההסבר הנכון לגבי חיסון הילדים?
א. החיסון המומת מכיל 4 זני וירוסים שונים ולכן יעילותו טובה יותר מהחיסון החי מוחלש.
ב. ניתן לחסן בחיסון חי מוחלש, הבן זקוק למנת חיסון אחת והבת זקוקה לשתי מנות חיסון.
ג. בת ה-6 זקוקה לחיסון מומת בשתי מנות נפרדות לעומת חיסון חי מוחלש במנה אחת.
ד. החיסון החי המוחלש ניתן תוך שרירית עם פחות תופעות של כאב מקומי לאחר מתן החיסון.
122. בן 20, HIV אנטיגן חיובי וספירת CD4 נמוכה מ-200.
מה ההמלצות לניהול המקרה כעת?
א. לבצע אק"ג, להשלים HbA1C, ולחסן Baxero ו-MMR.
ב. לבדוק פרופיל שומנים, HBsAg, HCV Ab ולחסן ב-Gardasil.
ג. לבדוק תפקודי כבד וכליות, לחסן ב-DTaP ו-Zostavax.
ד. תבחין עורי לשחפת PPD וחיסון פוליו OPV+OPV.
123. בן 70, סובל מ-COPD. בשנה האחרונה החמרה אחת עם אשפוז עקב דלקת ריאות. שולל קוצר נשימה במאמצים. מעבדה ללא אאוזינופיליה. בתפקודי ריאה
FEV1 48%, FEV1\FVC 0.68.
מה הטיפול ההתחלתי המתאים ביותר עבורו לפי GOLD?
א. Inhaled Corticosteroids (ICS) + Long acting Beta-agonists (LABA)
ב. Long acting beta agonists (LABA) + Long acting muscarinic antagonists (LAMA)
ג. Roflumilast (Daliresp)
ד. Azenil (Azithromycin)

124. קראת מחקר RCT בו לא צוין שהופעל עקרון Intention To Treat Analysis.

מה משמעות נתון זה לגבי תוצאות המחקר?

- א. התוצאות במחקר לא משקפות מחקר טיפולי (Intention To Treat).
- ב. התוצאות במחקר לא משקפות את המציאות וסביר להניח שאחוז הנשירה מהמחקר היה גבוה.
- ג. התוצאות במחקר משקפות את המציאות כיון שמדובר במחקר RCT עם Per Protocol Analysis שהיא שיטה מדויקת יותר לקבלת האפקט המצופה.
- ד. ביצוע Intention To Treat Analysis במחקר משקף את המציאות בעיקר על אותם נבדקים שעליהם התרופה לא השפיעה.

125. בת 35, בהריון שבוע 21. ביצעה בדיקות דם ושתן כחלק ממעקב הריון. בבדיקת שתן צמיחה של Streptococcus Group B (GBS) קטן מ-1000 CFU/ml. חשה בטוב, ללא תסמינים.

מה הטיפול המומלץ?

- א. מתן טיפול אנטיביוטי כעת וכן בלידה.
- ב. טיפול אנטיביוטי מניעתי בלידה.
- ג. טיפול אנטיביוטי בשלב זה.
- ד. אין צורך בטיפול עקב ממצא זה.

126. בן 50, בריא. פנה בשל פריחה אשר אובחנה כ-Rosacea.

מהו הטיפול המתאים ביותר כקו ראשון?

- א. קרם Elocom (Mometasone Furoate).
- ב. קרם Metronidazole.
- ג. משחת Benzac (Benzoyl Peroxide).
- ד. טיפול פומי ב-Minocycline.

127. בן 40, בריא בדרכו, פנה בשל צרבת מספר פעמים בשבוע מזה חודשיים. ללא כאבים בבליעה וללא שינוי במרקם או צבע היציאות. במעבדה אנמיה קלה מחוסר ברזל, המוגלובין 13.

על מה יש להמליץ בשלב הבא?

א. מעקב ושינוי אורחות חיים.

ב. ביצוע גסטרוסקופיה.

ג. US בטן.

ד. ביצוע pH monitoring.

128. בן 25, ממצא מקרי של אנוריסמה מוחית (Intracranial Aneurysm).

איזה מבין הנתונים הבאים מהווה סיכון לקרע של האנוריסמה?

א. היותו גבר בגיל צעיר.

ב. שותה שש כוסות קפה ביממה.

ג. משתמש בקוקאין במסיבות.

ד. מיקום אניוריסמה באונה פרונטלית.

129. בן 81, ברקע מחלת Hashimoto ו-Vitiligo, מלין על נימולים בידיים וכאב בלשון.

בבדיקות מעבדה:

נורמה	ערך	
	10.9	Hemoglobin (g/dl)
80-100	104	MCV (fl)
0.5-2.5	0.8	Reticulocyte Count (%)

איזו מבין הבדיקות הבאות תסביר את מצבו בסבירות הגבוהה ביותר?

א. רמת חומצה פולית.

ב. רמת ויטמין B12.

ג. LDH, הפטגלובין, בילירובין ישיר, קומבס ישיר.

ד. ברזל, טרנספרין ופריטין.

130. בת 17, בריאה, פונה בשל הממצא שבתמונה:



מהו הצעד הטיפולי הבא?

א. Topical retinoid plus benzoyl peroxide.

ב. Topical retinoid.

ג. Topical antibiotic.

ד. Oral Contraceptive.

131. בן 8 חודשים, בריא בד"כ, נולד בשבוע 30, ללא סיבוכים. לאחרונה אימו מספרת שכאשר בוכה בזמן החלפת חיתול, נצפה גוש במפשעה, כאשר נרגע הגוש נעלם. יציאות תקינות. בבדיקה, הילד נינוח, במפשעה הימנית ניתן למשש מסה חלקה וקשיחה שגדלה מעט כאשר הילד בוכה. אשכים נמושו בשק. בלחיצה על המסה ניתן להחזיר אותה פנימה.

מה הצעד הבא בניהול המקרה?

- א. הפניה דחופה לחדר מיון לניתוח מיידי.
- ב. הרמת הרגליים וקירור עם קרח למפשעה.
- ג. הערכת כירורג ילדים בקהילה לצורך ניתוח אלקטיבי בהקדם.
- ד. מדובר במצב שפיר שיחלוף עד גיל 5, בשלב זה מעקב בלבד.

132. בת 52 מתלוננת על ירידה חד צדדית בשמיעה וטנטון פולסטלי משמאל. בבדיקת שמיעה הפרעה הולכתית חד צדדית משמאל.

מהו החשד הקליני הסביר ביותר?

- א. מחלת מנייר (Ménière).
- ב. Acoustic neuromas.
- ג. Glomus Tumor.
- ד. Otitis Media with Effusio.

133. בת 32, חצי שנה לאחר לידה, הנקה מלאה. במסגרת בירור שהוחל לכאבי בטן, הומלץ על ביצוע CT עם מתן חומר ניגוד תוך ורידי. המטופלת מתייעצת מה עליה לעשות מבחינת ההנקה. מה נכון להמליץ לה בהקשר ההנקה?

- א. ניתן להמשיך הנקה כרגיל מיד לאחר הבדיקה.
- ב. ב-24 שעות הראשונות לאחר הבדיקה יש לבצע ריקון שד ואת החלב לזרוק.
- ג. ב-48 שעות הראשונות לאחר הבדיקה יש לבצע ריקון שד ואת החלב לזרוק.
- ד. עדיף להפנות את המטופלת לביצוע MRI עם גדוליניום.

134. איזה מבין המשפטים הבאים מתאר בצורה המדויקת ביותר את השיקולים לגבי הטיפול ב-Tamiflu (Oseltamivir) לשפעת עונתית?

א. במטופלים בסיכון גבוה לסיבוכי שפעת מומלץ להתחיל טיפול תרופתי ללא קשר למשך התסמינים.

ב. בנשים בהריון קיימת קונטרה-אינדיקציה לטיפול ב-Tamiflu.

ג. התחלת הטיפול מותנית בהוכחה מעבדתית של זיהום בשפעת בנוכחות קליניקה מתאימה.

ד. הטיפול לא מקצר את משך המחלה.

135. בן 48, סובל כ-10 שנים מ-Ulcerative Colitis. קולונוסקופיה אחרונה לפני כשנתיים הדגימה Pancolitis. מטופל ב-Rafassal (Mesalazine). תחת הטיפול מאוזן ומרגיש טוב, ללא שלשולים או כאבי בטן.

מהי ההמלצה לגבי המשך מעקב?

א. כל עוד המטופל מאוזן יש לבצע מעקב שנתי של רמות קלפרוטקטין בלבד.

ב. קולונוסקופיה כל 5 שנים.

ג. קולונוסקופיה כעת ובהמשך כל 1-2 שנים.

ד. בדיקת CT-Enterography כל שנתיים.

136. בן 45, מתלונן על כאב גב תחתון מזה שנה. בבדיקתו ללא חסר ניירולוגי, ללא חום, ללא הגבלה בתנועות הפרקים או הגב.

איזה מבין הנתונים הבאים יכול להוות דגל צהוב?

א. עובד בעבודה פיזית קשה.

ב. אמונה שכאב גב מזיק ויוביל לנכות.

ג. הכאב מוחמר במנוחה.

ד. רקע של שימוש בהרואין.

137. בת 27, פונה עקב פריחה שורפת ומגרדת בשתי הידיים מזה מספר ימים, כמתואר בתמונה.



מה הגורם השכיח ביותר למצב זה?

א. Papilloma Virus

ב. Herpes Simplex

ג. Adenovirus

ד. Rubella

138. בת 39, בריאה בד"כ. מגיעה בתלונה של הפרשה מפטמה שמאל. ילדה לפני שנתיים וחצי, הפסיקה להניק לפני שנתיים. סבתה אובחנה עם סרטן השד בגיל 74. בבדיקתה – הפרשה לבנבנה מפטמה שמאל, בלחיצה מופיעה בכמות קטנה גם מימין. לא נימושו גושים בשדיים.

מה הצעד הבא לקידום האבחנה?

א. בדיקת רמות Estrogen + Progesterone.

ב. בדיקה לרמות LH + FSH.

ג. בדיקת הריון.

ד. MRI מוח.

139. בת 45 פונה למרפאה עקב בלט עין מימין מזה מספר חודשים. בבדיקתה הממצא הבא:



איזו מבין הבדיקות הבאות היא החשובה ביותר באבחון הגורם למצבה?

א. שדה ראייה ממוחשב.

ב. CT ראש.

ג. רמת TSH.

ד. Schirmer Test.

בשאלות הבאות התשובה היא על דרך השלילה

140. בת 15 עולה בת 15 עולה חדשה, עברה כריתת טחול בגיל 7 על רקע Spherocytosis. בפנקס החיסונים מתועדים החיסונים הבאים: 4 מנות של PCV13 (Prevenar) ומנה אחת של PPV23 (Pneumovax) סמוך לכריתת הטחול.
- מומלץ לחסן את הנערה בכל החיסונים הבאים, **פרט ל?**
- א. מנה נוספת של תרכיב Pneumovax (PPV23).
- ב. Haemophilus Influenza Type B וחסון למנינגוקוק.
- ג. חיסון שפעת בתרסיס נזאלי מסוג Flumist.
- ד. 3 מנות של חיסון נגד נגיף הפפילומה Gardasil 9.
141. בעשור האחרון חלה עלייה בשכיחות (Prevalence) של COPD בקרב מטופלי המרפאה בה אתה עובד.
- כל ההסברים הבאים אפשריים, **פרט ל?**
- א. בשנים האחרונות הוכנס לסל התרופות משאף חדש שהוכח כמוריד תמותה בקרב חולי COPD.
- ב. לפני 5 שנים נוספה בדיקת תפקודי נשיפה לבדיקות הסקירה המומלצות עבור מעשנים 40 שנות קופסא ומעלה, מבוצע אחת ל-5 שנים.
- ג. לפני 10 שנים נפתח מרכז דיור לגיל הזהב בסמוך למרפאתך שרבים מדייריו הינם חקלאים לשעבר.
- ד. מחקר שנעשה בשנה האחרונה הראה עלייה ניכרת בשיעורי העישון בישראל בקרב צעירים בגילאי 18-25.

142. בן 80, ברקע יתר לחץ דם, רעד ראשוני. מטופל ב- Norvasc (Amlodipine) ו- Prolol (Propranolol). מלין על התכווצות בסובכים (Gastrocnemius) מזה שלושה חודשים. ללא תלונות נוספות.

כל הטיפולים הבאים מקובלים במצבו, **פרט ל?**

- א. הימנעות מ-Plantar Flexion של הרגל.
- ב. לשקול החלפת Norvasc (Amlodipine) ב-Tritace (Ramipril).
- ג. לשקול הפסקת / החלפת Propranolol.
- ד. הימנעות משתיה מופרזת של אלכוהול.

143. כל המטופלים הבאים מתלוננים על הפרעה בראיה המתאימה לירוד (Cataract), **פרט ל?**

- א. בן 60 המתלונן שיש גוון צהבהב-חום לכל מה שרואה, גם מקרוב וגם מרחוק.
- ב. בן 50 המתלונן על בוהק (glare) לבן בנהיגת לילה.
- ג. בן 40, מתלונן על ירידה בחדות הראייה דווקא כאשר ישנו אור חזק מסביב.
- ד. בת 60, מתלוננת על הופעת כתם במרכז שדה הראייה בשבועיים האחרונים.

144. בן 74, אובחן לאחרונה כסובל ממחלת אלצהיימר בדרגה בינונית ובעיות התנהגות ניכרות.

כל האפשרויות הטיפוליות הבאות מומלצות עבורו, **פרט ל?**

- א. Memantine (Namenda).
- ב. קנאביס רפואי.
- ג. טיפול נפשי.
- ד. Aduhelm (Aducanumab).

145. בת 64, ברקע השמנת יתר. סובלת מכאבי בשתי הברכיים שמוחמרים בירידה במדרגות ובנשיאת משקל. מוחמרים לקראת הערב ומוקלים במנוחה. בבדיקתה ללא אודם או חום מקומי.

כל ההמלצות הבאות מתאימות להקלת מצב המטופלת, **פרט ל?**

- א. להגביה את גובה האסלה.
- ב. להיעזר במקל הליכה.
- ג. לתרגל עלייה במדרגות.
- ד. לרדת במשקל.

146. בת 30 סובלת מזה כשנה וחצי מכאבים דו צדדיים באגן עם הקרנה לרקטום. הכאבים המופיעים מספר ימים לפני הווסת בזמן קיום יחסים עם חדירה עמוקה. בבדיקה הגופנית נמושה מסה אגנית רגישה. המטופלת מבקשת טיפול בשל הכאבים.

כל הטיפולים הבאים הוכחו כיעילים למצבה, **פרט ל?**

א. Decapeptyl (GnRH Analogue).

ב. Danazol (Danazol).

ג. Naxyn (Naproxen).

ד. Estrofem (Estradiol).

147. למי מהמטופלים המלינים כולם על שלשול מימי ללא דם או ריר וללא חום, **אין** לבצע

בדיקת צואה למזהמים?

א. בת 25, בריאה, מטפלת במעון ילדים. מזה 5 ימים שלשול.

ב. בן 27, בריא, סטודנט. שלשול מזה שבועיים.

ג. בן 45, בריא, עובד בניין. אושפז למשך יממה בשל כאבים בכתף. מרגע שחרורו מלין על שלשול.

ד. בת 57, מזכירה, ברקע Giant cell arteritis מטופלת בפרדניזון 10 מ"ג מזה 5 חודשים. שלשול מזה 5 ימים.

148. בת 30, ברקע השמנת יתר, תסמונת מטאבולית, סוכרת, עישון. מטופלת בגלולות משולבות למניעת הריון. נשאת של הגן Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC).

כל הבאים מהווים גורם סיכון לגידול ממאיר של רירית הרוחם במטופלת זו, **פרט ל?**

א. השמנת יתר.

ב. גלולות משולבות למניעת הריון.

ג. שחלות פוליציסטיות.

ד. נשאות של הגן HNPCC.

149. לכל המטופלים הבאים רופא חייב להעניק טיפול רפואי, פרט ל?
- א. אישה בהריון אשר מבקשת לבצע ניתוח קיסרי בניגוד להמלצה הרפואית.
 - ב. מטופל עם פגיעה קוגניטיבית אשר לא משתף פעולה.
 - ג. מטופל שעבר על דעת עצמו לטיפולו של רופא אחר וכעת מבקש לחזור.
 - ד. מטופל במצב חירום רפואי אשר בשל מצבו הגופני או הנפשי לא נתן הסכמה מדעת לביצוע הטיפול.

150. בת 45, נשואה ללא ילדים. מספרת כי בעלה מקלל ומעליב אותה וצועק עליה. אילו מהאמירות הבאות אין להגיד במפגש הרפואי עמה?
- א. "את לא אשמה ולאף אחד אין זכות לפגוע בך".
 - ב. "האם את מרגישה שחייך בסכנה והאם יש לך נשק?"
 - ג. "את לא צריכה מערכת יחסים כזו, הוא לא ראוי לך".
 - ד. "אם תרגישי מאוימת, האם יש לך לאן ללכת?"

בהצלחה